

Карточка Q&A · три прогнозируемых вопроса

Доклад «Не просто накормить...» · семинар 25–27.08.2026 · на стол спикеру. Шрифт 12 — читается на сцене с расстояния 1 м.

В 1. «Что показать проверяющему, который против вариативности?»

Не «второе меню», а систему. Комплект из 12 документов (раздел 31 доклада): положение о питании с разделом о вариативности, меню с парами эквивалентов, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты жителей, согласование с учредителем, лекарственно-пищевая таблица, список дисфагического риска, журнал отказов, приказ об ответственных (с фамилиями!), регламент совета жителей, квартальная панель 12 чисел. Отдельно — фотофиксация линии, акты бракеража, сверка с закупкой.

Показывать папкой, не слайдом: «вот положение, вот приказ, вот журнал за последние 30 дней, вот согласование учредителя». Спор прекращается, когда проверяющий видит, что вариативность — не самодеятельность, а процедура.

В 2. «Кто платит за дисфагический контур — логопеда, блендер, загуститель?»

Не «логопед», а пакет «без логопеда» (раздел 10.8). 4 элемента закрывают ~80% риска без ставки логопеда: (1) скрининг сиделками по 6 признакам (кашель, «мокрый» голос, долгое жевание, еда за щекой, подтекание, повторные пневмонии); (2) поза 90° + малые глотки + 30 мин без укладывания — бесплатно; (3) шкала IDDSI с тестами вилки/наклоном — повар осваивает за одно занятие; (4) алгоритм инцидента + 2 обученных человека на посту в часы еды.

Расходники (блендер, загуститель, поилки с клапаном) — дешевле одной аспирационной пневмонии. Логопед — отдельная строка (приказ Минтруда 520н, региональные нормативы ставок); если ставки нет — пакет всё равно работает, но в заявке учредителю пакет обосновывается как «первый шаг к ставке».

В 3. «Есть ли приговор или крупное дело, где учреждение наказали именно за отсутствие выбора еды?»

Нет — и не может быть: прямой обязанности выбора в законе нет. Но есть смежные составы, по которым учреждения реально привлекаются: **ст. 6.6 КоАП** — нарушение санитарных требований к организации питания (до 50 000 ₽ для юрлица или приостановление до 90 суток); **ст. 14.7 КоАП** — обман получателей услуг (если обещано в ИППСУ одно, а на деле другое); **ст. 238 УК** — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (при аспирационной пневмонии из-за неадекватной текстуры); **ст. 293 УК** — халатность (если житель умер от аспирации при отсутствии скрининга и журнала).

Комплект из 12 документов закрывает именно эти составы: записи о скрининге, акты бракеража, ИППСУ, согласование учредителя. Поэтому главный аргумент не «у нас есть выбор», а «у нас есть система, которая делает выбор безопасным и проверяемым».